



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 05-07-2024 23:35:38

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Marcelo Eduardo Carreno Moraga	Rut : 8.345.442-3	N° Archivo : 2412476	N° Epicrisis
Edad : 54a 11m 18d	Fecha Nacto : 17/07/1969	Sexo : Masculino	405288
Dirección : Ignacio Serrano 051	Comuna : La Granja	Teléfono : 9 5531 5721	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim	Fecha Ingreso : 25/06/2024	03:38	Días Estadía : 10
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso : 05/07/2024	23:07	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Marcelo Carreño Moraga
54 años
FI HPH: 16/06/24
FI CASR/UTIM: 24/06/24

Motivo de consulta: Traslado HPH para estudio pre-trasplante

Antecedentes:

- Mórbitos: DHC por OH Child C con ascitis intratable y várices esofágicas pequeñas (EDA febrero/24). En plan de trasplante hepático. Esofagitis grado B. Gastropatía crónica antral.
- Quirúrgicos: Apendicetomía a los 18 años.
- Fármacos: Carvedilol 3.125 mg al día, rifaximina 200 mg c/12 hrs. Omeprazol 20 mg al día SOS.
- Alergias: (-)
- Hábitos: TBQ (-), OH: inicio a los 16 años (vino, cerveza, destilados). Abstinente desde 1 diciembre 2023.
- Hospitalizaciones recientes: Enero 2024 debut de DHC con encefalopatía, se atribuye a constipación. Inicialmente con tratamiento empírico por sospecha de PBE, bolsillo no puncionable, completa 5 días.
- Social: Vive con esposa Luz y su hija menor. Educación técnico profesional, trabaja como taxista. Contacto: Luz Palma (esposa) 9-87002050.

Historia clínica:

Paciente con antecedentes descritos, es traído por compromiso de conciencia, de temporalidad no clara y sin otros síntomas. Al ingreso al servicio de urgencias se describe taquicárdico, normotenso, eupneico, afebril, apoyado con 3 l/min de O2 por NRC. Al examen físico destacaba ascitis, sin dolor abdominal. Laboratorio con anemia moderada y leve alza de parámetros inflamatorios (Hb 8.2, GB 12.200, PCR 20), hiperbilirrubinemia directa sin alteración significativa de las pruebas hepáticas (BiliT 6.8, Bili D 4.78, GOT 79, GPT 38, GGT 73, FA 170 INR 1.81), falla renal (BUN 45, crea 2.33 (en mayo creatinina en 1.7 y en junio 2.18), SO no inflamatorio ni hematuria, con UC (+) para SAMS. Antígeno COVID, influenza A y B negativos. TAC de tórax 18/06 (sin informe) se describe con foco de condensación basal izquierda y congestión pulmonar bibasal. Se hospitaliza para continuar manejo.

Evolución en HPH:
Fecha Epicrisis : 05/07/2024 23:35

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 05-07-2024 23:35:38

Página 2 de 4

- HDN: Se describe estable, sin exteriorización de sangrado, pero en contexto de anemización (por volemicación?) se transfunde glóbulos rojos (no sabemos cuánto). En lo sucesivo en relación a ecoscopia en la cual se observa disfunción diastólica leve pero con contractilidad adecuada y en contexto de sepsis, se decide apoyar con Dobutamina (hasta 3 ug/kg/min) y NAD (reemplazando la terlipresina) con meta de PAM > 75 mmHg para favorecer perfusión renal. Al traslado dobutamina a 3 ug/kg/min + NAD 0.18 mcg/kg/min, PAM 106.

- Respiratorio: Durante estadía se apoya con VMNI 14/8 FIO2 30% para disminución del trabajo ventilatorio con ventanas de CNAF de 4 horas a 25%/ 40 L. Se describe con buen intercambio pulmonar, sin mala mecánica ventilatoria.

- Gastro: Se describe paracentesis diagnóstica que descarta PBE, por lo cual se instala catéter para drenaje de líquido ascítico. Se estima drenaje de 8lt de forma paulatina a ritmo de 2 L cada 12 hrs con reposición de albúmina, posteriormente drenaje retirado. Cursando encefalopatía GII, en manejo con lactulosa. Se mantiene con IBP por antecedente de esofagitis y sospecha de sangrado digestivo y se administra vitamina K. Se solicita traslado a centro de referencia para trasplante hepático, con MeldNa 30 puntos y CLIF ACLF 55 puntos calculado al traslado. Aparentemente solo tiene pendiente estudio con MIBI dipiridamol para enlistarse.

- Renal: Evolucionan con falla renal y se sospecha secundaria a SHR, por lo que se inicia manejo con terlipresina y albúmina, con creatinina hasta 2.5, sin respuesta a manejo ni a medidas para optimizar perfusión renal. En contexto de síndrome edematoso se decide depleción con furosemida y tiazidas, logrando BH negativos. Función renal estacionaria con creatinina en 2.5 durante estadía, sin urgencia dialítica.

- Infeccioso: NAC en tratamiento empírico con ceftriaxona rotado a ampicilina sulbactam, en día 3 al ingreso (HPH? UTIM?). Se describe SO no inflamatorio con UC (+) para SAMS, sin embargo, con HC periféricos concomitantes negativos y sin otra clínica sugerente de endocarditis. No se describe mayor estudio. Hoy, previo a traslado se toman cultivos nuevos (periféricos, arrastre de CVC, UC) y se escala a imipenem + vancomicina empírico, alcanzando a recibir una dosis previo a traslado.

Últimos exámenes previo a traslado 24/06:

- (00:15): Lactato 2.2, BT 5.73, albúmina 3.2, Ca 9.3, P 3.2, LDH 242. Mg 2.3, BUN 49, Crea 2.42, GSA pH 7.41 PaCO2 36, HCO3 22, GSV pH 7.37, CO2 41, BIC 24, Hb 9, Gb 9600 RAN 7.000, plaquetas 110.000, INR 2.18, TTPA 73.

- (16:46): ELP 141/4.7/103, lactato 4.5 mmol/L, GSA pH 7.42, CO2 30, bic 19.6, O2 80.6. GSV pH 7.36, CO2 37, BIC 22, Gb 19100, RAN 15.000, plaquetas 137.000, INR 2.18, TTPA 54.

- (23:42): GSA pH 7.4, CO2 31, BIC 19. GSV: pH 7.37, CO2 34, BIC 20.

EVOLUCIÓN EN UCI

HDN: Mantiene shock que se interpreta como distributivo, inicialmente se trató con HFAV con respuesta parcial, evoluciona con altos requerimientos de DVA (NAD hasta 0.68 y Vasopresina a 0.04).

Anemia importante que requirió transfusiones múltiples.

Ventilatorio: Se mantuvo en VMI y con sedación profunda, PaFi deteriorada que mejora con tratamiento de Shock.

Se mantiene en AC volumen.

Infeccioso: Desde el traslado con Ceftazidima/Avibactam + Aztreonam por portación (sospecha de traslocación). Múltiples estudios de LA sin criterios de PBE.

Se solicitó BD glucano en 2 ocasiones con resultado pendiente.

Hepatología: CLIF ACLF 68 pts. MeldNa 44 puntos a su ingreso, persiste en similar gravedad. Por problemas:

- EH: Grado IV, deposiciones escasas. Apoyado con PEG + lactulosa + rifaximina. Evaluar uso de enemas para lograr deposición. Amonemia normalizada.

- Ascitis/PBE: Grado III-IV. Inicialmente en HPH con drenaje por pigtail, retirado al ingreso en CASR. Líquido ascítico sin PBE 25/06. Control líquido ascítico 65->195->13 células, sin cumplir criterios de PEB. Último estudio el 01/07 y evacuada el 27/06 3L. Se desestimó pigtail por coagulopatía.

- VE: VE pequeñas. Sin EDA, sin exteriorización de sangrado, anemización previamente descrita impresiona en relación a sangrado desde venopunciones.

- SHR: AKI en contexto de SHR con necesidad de TRR. Del estudio destaca FeBUN 29% (pre-renal), IPC límite (2) y microhematuria.

- Síntesis: Coagulopatía grave que recibió CPC y plasma, Hiperbilirrubinemia persistente. Hiperamonemia severa actualmente en rango normal.

THO: Equipo en seguimiento. Cuenta con estudio pré-THO prácticamente completo, excepto por MIBI. Dado gravedad clínica

Fecha Epicrisis : 05/07/2024 23:35

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 05-07-2024 23:35:38

Página 3 de 4

fuera de ventana para trasplante, por lo que se indicó manejo intensivo con reevaluación diaria.

Gastro: Cursando íleo adinámico, sin alteración electrolítica que lo explique, TAC TAP sin sufrimiento de asa ni factor obstructivo. Metoclopramida + PEG + Lactulosa.

Neuro: Evolucionó con compromiso de consciencia agudo por lo que requirió IOT, TAC cerebro sin lesiones agudas, sin signos de sangrado, interpretado en contexto de encefalopatía severa.

Renal: Inicialmente HFAV, luego terapia continua sin adecuada respuesta.

Con sospecha de SHR tipo 1, requirió Terlipresina.

Evaluable por Nefrología, se desestima nuevo procedimiento.

Profilaxis: Gastroprofilaxis. Se desestima tromboprofilaxis por Coagulopatía severa.

Extremadamente grave. Con requerimiento de NAD hasta 0.68 y Vasopresina hasta 0.04.

Recibió terapia dialítica continua sin respuesta.

Perfusión clínica alterada.

Fallece el 05/07/24 a las 22:30 hrs al lado de familiares.

Diagnósticos:

Falla multiorgánica

Shock distributivo profundo

DHC Child C descompensado, MELD-Na 35 ptos, ACLF-3, CLIF-C 68 ptos

- Sin descompensante identificado

- Ascitis GIII

- Encefalopatía WH IV

- SHR

- Coagulopatía

Shock distributivo obs 2rio ACLF

Insuficiencia respiratoria aguda multifactorial

- DP bilateral

- Edema pulmonar

- Anasarca

AKI KDIGO III sobre ERC, en TRR

Íleo adinámico sin sufrimiento de asa

Antecedentes: DHC por OH Child C con ascitis intratable y várices esofágicas pequeñas (EDA febrero/24). En plan de trasplante hepático. Esofagitis grado B. Gastropatía crónica antral.

Diagnóstico de Egreso

Daño Hepático Crónico -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece el 05/07/24.

Plan Post Alta

Se da aviso a familiares.

Se realiza certificado médico.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 05/07/2024 23:35

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:05

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 05-07-2024 23:35:38

Página 4 de 4

INTERNO

Becado/Residente

Mario Alex Contreras Torrez

Médico Tratante (Staff)